

보건복지부 고시 제2026-176호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2026-159호(2026. 7. 29.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 8월 27일
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

II. 약제 "[113] Fenfluramine hydrochloride 경구제(품명: 핀테플라액), [142] Sirolimus 시럽제(품명: 라파툼 시럽), [222] Budesonide + Formoterol fumarate + Glycopyrronium bromide 흡입제(품명: 브레즈트리에어로스피어흡입제 160/7.2/5.0마이크로그램), [259] Vibegron 경구제(품명: 베오바정50밀리그램)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[113] Cannabidiol(품명: 에피디올렉스내복액), [142] Golimumab 주사제(품명: 심퍼니프리필드시린지주 50밀리그램 등), [142] Secukinumab 주사제(품명: 코센틱스센소레디펜 등), [142] Ixekizumab 주사제(품명: 탈츠프리필드시린지주 등), [249] follitropin-α + lutropin α(r-hLH) 복합 주사제(품명: 퍼고베리스주), [439] Adalimumab 주사제(품명: 휴미라주 등), [439] Etanercept 주사제(품명: 엔브렐주사 등)"의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2026년 9월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[113] 항전간제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[113] Fenfluramine hydrochloride 경구제 (품명: 핀테플라액)	<신 설>	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. -아 래- ○ 2세 이상의 드라벳 증후군(Dravet syndrome) 환자에서 발작 치료를 위한 부가요법 1. 투여대상 3종 이상의 기존 항뇌전증약(Valproate, Clobazam 등)을 충분한 내약용량으로 투여하였으나 최초 항뇌전증약 투여시점 보다 50% 이상 발작 빈도 감소를 보이지 않은 환자 2. 투여방법 Cannabidiol과 병용투여는 인정하지 아니함.	○ Fenfluramine hydrochloride 경구제 (품명: 핀테플라액)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드 라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가 결과 등을 참고하여 급여기준을 신설함.

		3. 평가방법 가. 동 약제를 3개월간 사용 후 평가하여 동 약제 최초 투여시점 보다 50% 이상 경련발작(convulsive seizure) 또는 모든 종류의 발작 빈도가 감소한 경우 3개월의 추가 투여를 인정함. 나. 이후에는 3개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 다. 발작 빈도 및 투약 등의 확인을 위한 일지(seizure calendar)를 환자 및 보호자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함. ※ 허가사항 중 용법·용량 및 사용상의 주의사항(경고, 다음 환자에는 투여하지 말 것 등)을 준수하여 투여하여야 함	
--	--	--	--

※ 관련근거 · FDA (2020.6.), EMA (2020.12.), TGA (2024.11.) · Nelson Textbook of Pediatrics 22th Edition.(2025.) · Katzung’s Basic & Clinical Pharmacology, 16th Edition.(2024.) · Goodman & Gilman’s Manual of Pharmacology and Therapeutics 14th edition.(2023.) · Conn’s Current Therapy 2025. > Seizures and Epilepsy in Adolescents and Adults · International consensus on diagnosis and management of Dravet syndrome.(2022.) · A Practical Guide to the Treatment of Dravet Syndrome with Anti-Seizure Medication.(2022.) · Lieven Lagae et al. Fenfluramine hydrochloride for the treatment of seizures in Dravet syndrome: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2019 Dec 21;394(10216):2243-2254. · Rima Nabbout et al. Fenfluramine for Treatment-Resistant Seizures in Patients With Dravet Syndrome Receiving Stiripentol-Inclusive Regimens A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2020 Mar 1;77(3):300-308. · Joseph Sullivan et al. Fenfluramine in the treatment of Dravet syndrome: Results of a third randomized, placebo-controlled clinical trial. Epilepsia. 2023;64:2653 – 2666. · Ingrid E. Scheffer et al. Long-term safety and effectiveness of fenfluramine in children and adults with Dravet syndrome. Epilepsia. 2025;00:1 – 14.			
--	--	--	--

· Guerrini R et al. Comparative efficacy and safety of stiripentol, cannabidiol and fenfluramine as first-line add-on therapies for seizures in Dravet syndrome: A network meta-analysis. Epilepsia Open. 2024;9:689 – 703.12. · NICE(2022.), SMC(2023.)

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Sirolimus 시럽제 (품명 : 라파문 시럽)	<신 설>	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 투여 시 약값 전액을 환자가 부담토록 함. ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위 장기이식거부 반응	○ 동일성분 정제가 요양급여 인정되고 있어 식품의약품안전처 인정범위에 대하여 요양급여 인정 필요성은 적어보이므로 전액 본인 부담하는 것이 적절하다는 의견임을 급여기준을 신설
※ 관련근거 <요양급여 신규등제에 따른 급여기준 신설>			

[222] 진해거담제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[222] Budesonide + Formoterol fumarate + Glycopyrronium bromide 흡입제 (품명:브레스트리 에어로스피어흡입제 160/7.2/5.0마이크 로그램)	<신 설>	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 중등도 이상의 성인(만 18세 이상) 만성폐쇄성폐질환 가. 지속성 베타2-효능약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합요법에도 불구하고 다음의 조건을 만족할 경우 - 다 음 - 1) FEV1 값이 예상 정상치의 60% 미만인 경우 또는 2) 연 2회 이상 급성악화가 발생한 경우(투여소견서 참조하여 인정) ※ 급성악화는 호흡곤란의 악화, 기침의 증가, 가래양의 증가 또는 가래색의 변화 등으로 약제의 변경 또는 추가(항생제·스테로이드제 등)가 필요한 경우를 말함 나. 지속성 베타2-효능약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법에도 불구하고 호흡곤란 등의 증상이 적절히 조절되지 않는 경우	○ Budesonide + Formoterol fumarate + Glycopyrronium bromide 흡입제(품명:브레스트리 에어로스피어) 160/7.2/5.0 마이크로그램)가 신규 등재 예정임에 따라 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 및 전문가의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여 기준을 신설함
※ 관련근거 · Goldman-Cecil Medicine, 27e (2024) · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e(2025)			

· Current Medical Diagnosis & Treatment (2026) · GLOBAL INITIATIVE FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE(GOLD guideline, 2026) · 대한결핵 및 호흡기학회 COPD 진료지침 (2024) · Triple Inhaled Therapy at Two Glucocorticoid Doses in Moderate-to-Very-Severe COPD N Engl J Med 2020;383:35-48. · Triple therapy with budesonide/glycopyrrolate/formoterol fumarate with co-suspension delivery technology versus dual therapies in chronic obstructive pulmonary disease (KRONOS): a double-blind, parallel-group, multicentre, phase 3 randomised controlled trial Lancet Respir Med 2018;6: 747-58 · Efficacy of Budesonide/Glycopyrronium/Formoterol Fumarate Metered Dose Inhaler (BGF MDI) Versus Other Inhaled Corticosteroid/Long-Acting Muscarinic Antagonist/Long-Acting b2-Agonist (ICS/LAMA/LABA) Triple Combinations in COPD: A Systematic Literature Review and Network Meta-analysis Adv Ther (2020) 37:2956-2975 · Mortality risk reduction with budesonide/glycopyrrolate/formoterol fumarateversus fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol in COPD: a matching-adjusted indirect comparison based on ETHOS and IMPACT CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION (2023) · Triple Therapy in COPD in Real Life: Is It Better to Use Single or Multiple Inhalers? J.Clin. Med. (2024) · 대한천식알레르기학회(대알학 제2025-158호, 2025.12.12.) · 대한결핵 및 호흡기학회(결학 제2025-611호, 2025.12.17.) · NICE(19.7.26), SMC(21.1.15.), PBAC(21.7.1), CDA-AMC(21.8.26)

[259] 기타의 비뇨생식기관 및 항문용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[259] Vibegron 경구제 (품명 : 베오바정50밀리그램)	<신 설>	허가사항 범위(과민성 방광의 배뇨 절박감, 빈뇨 및 절박성 요실금 증상의 치료) 내에서 투여 시 요양급여를 인정함.	○ Vibegron 경구제 (품명 : 베오바정 50밀리그램)가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이

			드라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가 결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.
※ 관련근거 1) Quick Medical Diagnosis & Treatment 2025 2) Current Medical Diagnosis & Treatment 2026 3) The AUA/SUFU Guideline on the Diagnosis and Treatment of Idiopathic Overactive Bladder (2024) 4) Masaki Yoshida et al. Vibegron, a Novel Potent and Selective b3-Adrenoreceptor Agonist, for the Treatment of Patients with Overactive Bladder: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study EUROPEAN UROLOGY 2018;73;pages 783-790. 5) Masaki Yoshida et al. Long-term safety and efficacy of the novel b3-adrenoreceptor agonist vibegron in Japanese patients with overactive bladder: A phase III prospective study INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY 2018;25;pages 668-675. 6) Manami Kinjo et al. Comparison of Mirabegron and Vibegron in Women With Treatment- Naive Overactive Bladder: A Randomized Controlled Study UROLOGY 2023;175;pages 67-73. 7) Zhonyu Jian et al. Vibegron 50 mg is the optimal algorithm in the pharmacologic management of overactive bladder: outcomes from a systematic review and meta analysis International Urology and Nephrology 2020;12;pages 2215-2221. 8) 대한산부인과학회(제27-081호, 2025.12.3.), 대한비뇨의학회 (대비뇨 2025-(22)-보126, 2025.12.10.) 9) NICE(2024.9.4.) 10) SMC(2024.12.9.)			

[별지 2]

[113] 항전간제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[113] Cannabidiol (품명: 에피디올렉스내복액)	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - <u><추 가></u> <u>가.</u> 투여대상 valproate, clobazam, topiramate, stiripentol, clonazepam, levetiracetam, zonisamide, ethosuximide, phenobarbital, lamotrigine, rufinamide 중 5종 이상 약제를 충분한 내약 용량으로 투여하였으나 최초 항전간제 투여 시점 보다 50%이상 발작 감소를 보이지 않은 환자	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - <u>가. 투여대상 및 투여방법</u> 1) 2세 이상 환자의 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut syndrome) 또는 드라벡 증후군(Dravet syndrome)과 관련된 발작(seizure)의 치료 <u>가)</u> 투여대상 Valproate, Clobazam, Topiramate, Stiripentol, Clonazepam, Levetiracetam, Zonisamide, Ethosuximide, Phenobarbital, Lamotrigine, Rufinamide 중 3종 이상 약제를 충분한 내약 용량으로 투여하였으나 최초 항뇌전증약 투여시점 보다 50%이상 발작 빈도 감소를 보이지 않은 경우	○ 임상진료지침, 임상연구 문헌, 전문가 의견 등을 고려하여 선행투여약제 개수를 5종에서 3종으로 변경하고 적응증별로 발작종류 구분하여 평가방법을 변경하였으며, 식품의약품안전처장이 인정한 범위 변경 고려하여 복합 결절성 경화증(Tuberous sclerosis complex)과 관련된 발작(seizure)의 치료에 급여 확대함. ○ 용어정비 - 발작 감소→발작 빈도 감소 - 항전간제 → 항뇌전증약 ○ 식약처장 인정범위 문구 간 소화(투여용량 기재 삭제)

	나. 투여방법 Clobazam과 병용 투여함.(단, Clobazam에 금기 또는 부작용으로 투여할 수 없는 경우 단독투여를 인정함) <u><추 가></u> 다. 평가방법 1) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가하여 동 약제 <u>최초 투여시점 보다 50%이상 발작</u>이 감소한 경우 3개월의 추가 투여를 인정함. <u><추 가></u>	나) 투여방법 (1) Clobazam과 병용 투여함.(단, Clobazam에 금기 또는 부작용으로 투여할 수 없는 경우 단독투여를 인정함) (2) Fenfluramine과 병용투여는 인정하지 않함. 2) 2세 이상 환자의 복합 결절성 경화증(Tuberous sclerosis complex)과 관련된 발작(seizure)의 치료 ○ 투여대상 <u>5종 이상의 항뇌전증약을 충분한 내약용량으로 투여하였으나 최초 항전간제 투여시점 보다 50%이상 발작 감소를 보이지 않은 경우</u> 나. 평가방법 1) 동 약제를 3개월간 사용 후 평가하여 동 약제 <u>최초 투여시점보다 다음의 발작 빈도가 50% 이상 감소한 경우</u> 3개월의 추가 투여를 인정함. - 다 음 - 가) 레녹스-가스토 증후군: 쓰러짐발작(drop seizure)	
--	--	--	--

	빈도, 모든 종류의 발작 빈도 나) 드라벡증후군: 경련발작(convulsive seizure) 빈도, 모든 종류의 발작 빈도 다) 복합 결절성 경화증(Tuberous sclerosis complex): 쓰러짐발작(drop seizure) 빈도 또는 경련발작(convulsive seizure) 빈도, 모든 종류의 발작 빈도 2) 이후에는 3개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 3) 발작 빈도 및 투약 등의 확인을 위한 일지(seizure calendar)를 환자 및 보호자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함 ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위 ○ 투여대상 2세 이상 환자의 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut syndrome) 또는 드라벡 증후군(Dravet syndrome)과 관련된 발작(seizure)의 치료 ○ 투여용량 1) 시작용량: 2.5mg/kg 하루 2회 복용(5mg/kg/day)	빈도, 모든 종류의 발작 빈도 나) 드라벡증후군: 경련발작(convulsive seizure) 빈도, 모든 종류의 발작 빈도 다) 복합 결절성 경화증(Tuberous sclerosis complex): 쓰러짐발작(drop seizure) 빈도 또는 경련발작(convulsive seizure) 빈도, 모든 종류의 발작 빈도 2) 이후에는 3개월마다 평가하여 첫 3개월째의 평가 결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 3) 발작 빈도 및 투약 등의 확인을 위한 일지(seizure calendar)를 환자 및 보호자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함. ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위: ○ 투여대상<삭 제> 1세 이상 환자의 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut syndrome), 드라벡 증후군(Dravet syndrome) 또는 복합 결절성 경화증(Tuberous sclerosis complex)과 관련된 발작(seizure)의 치료 ○ 투여용량<삭 제> 1) 시작용량: 2.5mg/kg 하루 2회 복용(5mg/kg/day)	
--	--	---	--

	2) 유지용량: 투약 1주 후 5mg/kg 하루 2회 복용(10mg/kg/day)으로 증량할 수 있음. - 최대 권장 유지 용량: 내약성이 좋고, 발작 감소가 필요한 환자들은 10mg/kg 하루 2회복용(20mg/kg/day)으로 증량할 수 있으며, 주마다 2.5mg/kg 하루 2회(5mg/day) 증량하도록 한다. * 10mg/kg/day에서 20mg/kg/day로 빠르게 증량이 가능하다고 판단되는 환자의 경우, 2일 이상의 간격을 두고 증량할 수 있다.	2) 유지용량: 투약 1주 후 5mg/kg 하루 2회 복용(10mg/kg/day)으로 증량할 수 있음. - 최대 권장 유지 용량: 내약성이 좋고, 발작 감소가 필요한 환자들은 10mg/kg 하루 2회복용(20mg/kg/day)으로 증량할 수 있으며, 주마다 2.5mg/kg 하루 2회(5mg/day) 증량하도록 한다. * 10mg/kg/day에서 20mg/kg/day로 빠르게 증량이 가능하다고 판단되는 환자의 경우, 2일 이상의 간격을 두고 증량할 수 있다.
--	--	--

※ 관련근거

- Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: Updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group(2018)
- Updated clinical recommendation for the management of tuberous sclerosis complex associated epilepsy(2022)
- International consensus on diagnosis and management of Dravet syndrome(2023)
- Expert Opinion on the Management of Lennox-Gastaut Syndrome; treatment algorithms and practical considerations(2017)
- Urszula Skrobas, et al. Ketogenic Diets in the Management of Lennox-Gastaut Syndrome–Review of Literature. Nutrients.2022;14(23):4977.
- Yan-Qiu Wang, et al, Efficacy of the ketogenic diet in patients with Dravet syndrome: A meta-analysis, Seizure.2020;81:36-42.
- Yu Fang, et al, Ketogenic Diet therapy for drug-resistant epilepsy and cognitive impairment in children with tuberous sclerosis complex. Front Neurol.2022;13:863826.
- Elizabeth G Neal, et al, The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial, Lancet Neurol. 2008;7:500-506.
- Maxine Dibue, et al, Vagus nerve stimulation in patients with Lennox-Gastaut syndrome: A meta-analysis. Acta Neurol Scand.

2021;143:497-508.

- Zhirong Wei, MM et al, Effectiveness of Vagus Nerve Stimulation in Patients With Dravet Syndrome: A Case Series and Meta-Analysis, A Pediatr Neurol. 2025;164.105-114.
- Nelia Zamponi, MD et al, Vagus Nerve Stimulation for Refractory Epilepsy in Tuberous Sclerosis. Pediatric neurology. 2010;43(1);29-34.

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Golimumab 주사제 (품명: 심퍼니프리펠드시 린지주 50밀리그램 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (중 략) <신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (중 략) 마. 중증의 활동성 비방사선 축성 척추관절염 ※ 비방사선 축성 척추관절염 : ASAS axSpA classification criteria를 근거로 축성 척추관절염이 진단되고, 방사선학적으로 확인되지 않으나 MRI 상 객관적인 염증의 징후를 보이는 경우 1) 투여대상 (모두 만족)	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 비방사선 축성 척추관절염에 급여 확대

		가) 두 가지 종류 이상의 비스테로이드항염제(NSAIDs) 혹은 DMARDs로 3개월 이상 치료를 하였으나 치료효과가 미흡하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한 경우 나) Bath 강직성 척추염의 질병 활동 지수(BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)가 적어도 4 이상인 경우 다) CRP가 정상 상한치 이상이고, MRI 상 Bone marrow edema와 같은 객관적인 염증이 확인되는 경우 2) 평가방법 가) 투여 3개월째 평가를 통하여 Bath 강직성 척추염 활성도(BASDAI)가 50% 또는 2(scale 0-10)이상 감소한 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가를 하여 첫 3개월째의 평가결과가 유지되면 추가투여를 인정함. (이하 생략)	
※ 관련근거 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e, 2025> Chapter 374: Spondyloarthritis · Conn's Current Therapy, 2024> 993-996, Axial Spondyloarthritis · Davidson's Principles and Practice of Medicine, 26e, 2023> 989-1062, Rheumatology and bone disease			

· ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update · Pan American League of Associations for Rheumatology recommendations for the management of axial spondyloarthritis, 2023 · 2019 update of the Americal College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Sponyloarthritis Research and Treatment Network Recommendation for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis · Johanna Callhoff, et al. Efficacy of TNFα blockers in patients with ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis: a meta-analysis Ann Rheum dis, 2015, Jun, 74(6), 1241-8 · Sieper, J., et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Sixteen-Week Study of Subcutaneous Golimumab in Patients With Active Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis & Rheumatology, 2015, 67(10), 2702-2712. · Mitsumasa Kishimoto, et al. Clinical characteristics of non-radiographic versus radiographic axial spondyloarthritis in Asia and non-radiographic axial spondyloarthritis in other regions: results of the cross-sectional ASAS-COMOSPA study, RMD open, 2021, 7:e001752 · Xabier Michelena, et al. Non-radiographic versus radiographic axSpA: what's in a name?, Rheumatology (Oxford). 2020 Oct 14;59(Suppl 4):iv18-iv24 · Dennis McGonagle, et al. A strategy towards disentangling treatment refractory from misdiagnosed axial Spondyloarthritis, Autoimmunity Reviews, Volume 23, Issue 1, 2024 Jan 103405 · M Rudwaleit, et al. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging (MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS/OMERACT MRI group, Annals of the Rheumatic Disease, 2009, 68(10), 1520-1527 · Robert G W Lambert, et al. Defining active sacroiliitis on MRI for classification of axial spondyloarthritis: update by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2016, 75(11), 1958-1963 · Walter P Maksymowych, et al. MRI lesions in the sacroiliac joints of patients with spondyloarthritis: an update of definitions and validation by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2019, 78(11), 1550-1558 · Xenofon Baraliakos, et al. MRI lesions of the spine in patients with axial spondyloarthritis: an update of lesion definitions and validation by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2022, 81(9), 1243-1251 · NICE(2016.2.) · PBAC(2020.11.) · SMC(2013.4.) · AETNA(2025.10.)

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	

[142] Secukinumab 주사제(품명: 코센틱스센소레디펜 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (중 략) <u><신 설></u>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (중 략) 마. 중증의 활동성 비방사선 측정 척추관절염 ※ 비방사선 측정 척추관절염 : ASAS axSpA classification criteria를 근거로 측정 척추관절염이 진단되고, 방사선학적으로 확인되지 않으나 MRI 상 객관적인 염증의 징후를 보이는 경우 1) 투여대상 (모두 만족) 가) 두 가지 종류 이상의 비스테로이드항염제(NSAIDs) 혹은 DMARDs로 3개월 이상 치료를 하였으나 치료효과가 미흡하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한 경우 나) Bath 강직성 척추염의 질병 활동 지수(BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)가 적어도 4 이상인 경우 다) CRP가 정상 상한치 이상이고, MRI 상 Bone marrow edema와 같은 객관적인 염증이 확인되는 경우	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 학회(전문가) 의견 등을 참조하여 비방사선 측정 척추관절염에 급여 확대
--	--	--	--

	(이하 생략)	2) 평가방법 가) 동 약제를 16주간 사용 후 평가하여 BASDAI가 50% 또는 2(Scale 0-10) 이상 감소한 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 16주째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함 (이하 생략)	
※ 관련근거 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e, 2025> Chapter 374: Spondyloarthritis · Conn's Current Therapy, 2024> 993-996, Axial Sponyloarthritis · Davidson's Principles and Practice of Medicine, 26e, 2023> 989-1062, Rheumatology and bone disease · ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update · Pan American League of Associations for Rheumatology recommendations for the management of axial spondyloarthritis, 2023 · 2019 update of the Americal College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Sponyloarthritis Research and Treatment Network Recommendation for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis · Atul Deodhar, et al. Improvement of Signs and Symptoms of Nonradiographic Axial Spondyloarthritis in Patients Treated With Secukinumab: Primary Results of a Randomized, Placebo-Controlled Phase III Study, Arthritis & Rheumatology 2021, 73(1), 110-120 · Mitsumasa Kishimoto, et al. Clinical characteristics of non-radiographic versus radiographic axial spondyloarthritis in Asia and non-radiographic axial spondyloarthritis in other regions: results of the cross-sectional ASAS-COMOSPA study, RMD open, 2021, 7:e001752 · Xabier Michelena, et al. Non-radiographic versus radiographic axSpA: what's in a name?, Rheumatology (Oxford). 2020 Oct 14;59(Suppl 4):iv18-iv24 · Dennis McGonagle, et al. A strategy towards disentangling treatment refractory from misdiagnosed axial Spondyloarthritis, Autoimmunity Reviews, Volume 23, Issue 1, 2024 Jan 103405 · M Rudwaleit, et al. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging (MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS/OMERACT MRI group, Annals of the Rheumatic Disease, 2009, 68(10), 1520-1527 · Robert G W Lambert, et al. Defining active sacroiliitis on MRI for classification of axial spondyloarthritis: update by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2016, 75(11), 1958-1963 · Walter P Maksymowych, et al. MRI lesions in the sacroiliac joints of patients with spondyloarthritis: an update of definitions and validation by the			

ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2019, 78(11), 1550-1558 · Xenofon Baraliakos, et al. MRI lesions of the spine in patients with axial spondyloarthritis: an update of lesion definitions and validation by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2022, 81(9), 1243-1251 · NICE(2016.2.) · PBAC(2020.11.) · SMC(2013.4.) · AETNA(2025.10.)

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142] Ixekizumab 주사제 (품명: 탈츠프리 필드시린지주 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으 로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토 록 함. - 아 래 - (중 략) <신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으 로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토 록 함. - 아 래 - (중 략) 라. 중증의 활동성 비방사선 축성 척추관절염 ※ 비방사선 축성 척추관절염 : ASAS axSpA classification criteria를 근거로 축성 척추관절 염이 진단되고, 방사선학적으로 확인되지 않으나 MRI 상 객관적인 염증의 징후를 보이는 경우 1) 투여대상 (모두만족) 가) 두 가지 종류 이상의 비스테로이드항염	○ 교과서, 가이드라인, 임 상연구문헌, 학회(전문 가) 의견 등을 참조하여 비방사선 축성 척추관절 염에 급여 확대

		제(NSAIDs) 혹은 DMARDs로 3개월 이상 치료를 하였으나 치료효과가 미흡 하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치 료를 중단한 경우 나) Bath 강직성 척추염의 질병 활동 지수 (BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)가 적어도 4 이상인 경우 다) CRP가 정상 상한치 이상이고, MRI 상 Bone marrow edema와 같은 객관적인 염증이 확인되는 경우 2) 평가방법 가) 동 약제를 16주간 사용 후 평가하여 BASDAI가 50% 또는 2(Scale 0-10) 이상 감소한 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가하여 첫 16주 째의 평가결과가 유지되면 지속적인 투 여를 인정함. (이하 생략)	
※ 관련근거 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e, 2025> Chapter 374: Spondyloarthritis · Conn's Current Therapy, 2024> 993-996, Axial Spondyloarthritis · Davidson's Principles and Practice of Medicine, 26e, 2023> 989-1062, Rheumatology and bone disease · ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update			

- Pan American League of Associations for Rheumatology recommendations for the management of axial spondyloarthritis, 2023
- 2019 update of the Americal College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Sponyloarthritis Research and Treatment Network Recommendation for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis
- Atul Deodhar, et al. Ixekizumab for patients with non-radiographic axial spondyloarthritis (COAST-X): a randomised, placebo-controlled trial, Lancet, 2020, 395, 53-64
- Mitsumasa Kishimoto, et al. Clinical characteristics of non-radiographic versus radiographic axial spondyloarthritis in Asia and non-radiographic axial spondyloarthritis in other regions: results of the cross-sectional ASAS-COMOSPA study, RMD open, 2021, 7:e001752
- Xabier Michelena, et al. Non-radiographic versus radiographic axSpA: what's in a name?, Rheumatology (Oxford). 2020 Oct 14;59(Suppl 4):iv18-iv24
- Dennis McGonagle, et al. A strategy towards disentangling treatment refractory from misdiagnosed axial Spondyloarthritis, Autoimmunity Reviews, Volume 23, Issue 1, 2024 Jan 103405
- M Rudwaleit, et al. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging (MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS/OMERACT MRI group, Annals of the Rheumatic Disease, 2009, 68(10), 1520-1527
- Robert G W Lambert, et al. Defining active sacroiliitis on MRI for classification of axial spondyloarthritis: update by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2016, 75(11), 1958-1963
- Walter P Maksymowych, et al. MRI lesions in the sacroiliac joints of patients with spondyloarthritis: an update of definitions and validation by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2019, 78(11), 1550-1558
- Xenofon Baraliakos, et al. MRI lesions of the spine in patients with axial spondyloarthritis: an update of lesion definitions and validation by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2022, 81(9), 1243-1251
- NICE(2016.2.)
- PBAC(2020.11.)
- SMC(2013.4.)
- AETNA(2025.10.)

[249] 기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함)						
구 분	세부인정기준 및 방법		구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행			개 정(안)		
[249] follitropin-α +	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하		[249] follitropin-α +	1. (현행과 같음)		○ 「follitropin-α +

[249] 기타의 호르몬제(항호르몬제를 포함)						
구 분	세부인정기준 및 방법		구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행			개 정(안)		
lutropin α(r-hLH) 복합주사제 (품명: 퍼고베리스주 ＜추 가＞)	며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액 을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (생 략) 나. LH결핍 환자의 보조생식술에 2바 이알/day까지 투여한 경우 2. (생 략) 3. (생 략)		lutropin α(r-hLH) 복합주사제 (품명: 퍼고베리스주 등)	- 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. LH결핍 환자의 보조생식술에 follitropin-α 300IU, lutropin α 150IU/day까지 투여한 경우 2. (현행과 같음) 3. (현행과 같음)		lutropin α(r-hLH) 복합주사제(품명: 퍼 고베리스주)」급여기 준에 따라 요양급여 인정함. 단, 고시 구 분의 품명에 ‘등’ 추 가 및 세부인정기준 및 방법의 바이알 단위를 ‘성분의 IU 단위’로 변경함.
※ 관련근거 ＜요양급여 신규등제에 따른 급여기준 변경＞						

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[439]	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 학회(전문

Adalimumab 주사제(품명: 휴미라주 등)	정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토 록 함. - 아 래 - (중 략) <u><신 설></u>	정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토 록 함. - 아 래 - (중 략) 카. 중증의 활동성 비방사선 축성 척추관절염 ※ 비방사선 축성 척추관절염 : ASAS axSpA classification criteria를 근거로 축성 척추관절 염이 진단되고, 방사선학적으로 확인되지 않으나 MRI 상 객관적인 염증의 징후를 보이는 경우 1) 투여대상 (모두 만족) 가) 두 가지 종류 이상의 비스테로이드항염 제(NSAIDs) 혹은 DMARDs로 3개월 이상 치료를 하였으나 치료효과가 미흡 하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치료를 중단한 경우 나) Bath 강직성 척추염의 질병 활동 지수 (BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) 가 적어도 4 이상인 경우 다) CRP가 정상 상한치 이상이고, MRI 상 Bone marrow edema와 같은 객관적인 염증이 확인되는 경우 2) 평가방법	가) 의견 등을 참조하여 비방사선 축성 척추관절 염에 급여 확대
----------------------------------	---	--	---

	(이하 생략)	가) 투여 3개월째 평가를 통하여 Bath 강직 성척추염 활성도(BASDAI)가 50% 또 는 2(scale 0-10)이상 감소한 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가를 하여 첫 3 개월째의 평가결과가 유지되면 추가투 여를 인정함. (이하 생략)	
※ 관련근거 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e, 2025> Chapter 374: Spondyloarthritis · Conn's Current Therapy, 2024> 993-996, Axial Sponyloarthritis · Davidson's Principles and Practice of Medicine, 26e, 2023> 989-1062, Rheumatology and bone disease · ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update · Pan American League of Associations for Rheumatology recommendations for the management of axial spondyloarthritis, 2023 · 2019 update of the Americal College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Sponyloarthritis Research and Treatment Network Recommendation for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis · Johanna Callhoff, et al. Efficacy of TNFα blockers in patients with ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis: a meta-analysis Ann Rheum dis, 2015, Jun, 74(6), 1241-8 · Sieper, J., et al. Efficacy and safety of adalimumab in patients with non-radiographic axial spondyloarthritis: results of a randomised placebo-controlled trial (ABILITY-1). Annals of the Rheumatic diseases, 2013, 72, 815-822 · Landewe, R., et al. Efficacy and safety of continuing versus withdrawing adalimumab therapy in maintaining remission in patients with non-radiographic axial spondyloarthritis (ABILITY-3): a multicentre, randomised, double-blind study. The Lancet, 2018, 392, 134-144. · Mitumasa Kishimoto, et al. Clinical characteristics of non-radiographic versus radiographic axial spondyloarthritis in Asia and non-radiographic axial spondyloarthritis in other regions: results of the cross-sectional ASAS-COMOSPA study, RMD open, 2021, 7:e001752 · Xabier Michelena, et al. Non-radiographic versus radiographic axSpA: what's in a name?, Rheumatology (Oxford). 2020 Oct 14;59(Suppl 4):iv18-iv24 · Dennis McGonagle, et al. A strategy towards disentangling treatment refractory from misdiagnosed axial Spondyloarthritis, Autoimmunity Reviews, Volume 23, Issue 1, 2024 Jan 103405 · M Rudwaleit, et al. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging (MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS/OMERACT MRI group, Annals of the Rheumatic Disease, 2009, 68(10), 1520-1527			

- Robert G W Lambert, et al. Defining active sacroiliitis on MRI for classification of axial spondyloarthritis: update by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2016, 75(11), 1958-1963
- Walter P Maksymowych, et al. MRI lesions in the sacroiliac joints of patients with spondyloarthritis: an update of definitions and validation by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2019, 78(11), 1550-1558
- Xenofon Baraliakos, et al. MRI lesions of the spine in patients with axial spondyloarthritis: an update of lesion definitions and validation by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2022, 81(9), 1243-1251
- NICE(2016.2.)
- PBAC(2020.11.)
- SMC(2013.4.)
- AETNA(2025.10.)

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[439] Etanercept 주사제 (품명: 엔브렐주사 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으 로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토 록 함. - 아 래 - (중 략) <u><신 설></u>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으 로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토 록 함. - 아 래 - (중 략) 바. 중증의 활동성 비방사선 축성 척추관절염	○ 교과서, 가이드라인, 임 상연구문헌, 학회(전문 가) 의견 등을 참조하여 비방사선 축성 척추관절 염에 급여 확대

	※ 비방사선 축성 척추관절염 : ASAS axSpA classification criteria를 근거로 축성 척추관절 염이 진단되고, 방사선학적으로 확인되지 않으나 MRI 상 객관적인 염증의 징후를 보이는 경우 1) 투여대상 (모두 만족) 가) 두 가지 종류 이상의 비스테로이드항염 제(NSAIDs) 혹은 DMARDs로 3개월 이상 치료를 하였으나 치료효과가 미흡 하거나, 상기 약제들의 부작용 등으로 치 료를 중단한 경우 나) Bath 강직성 척추염의 질병 활동 지수 (BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)가 적어도 4 이상인 경우 다) CRP가 정상 상한치 이상이고, MRI 상 Bone marrow edema와 같은 객관적인 염증이 확인되는 경우 2) 평가방법 가) 투여 3개월째 평가를 통하여 Bath 강직 성척추염 활성도(BASDAI)가 50% 또 는 2(scale 0-10)이상 감소한 경우 추 가 6개월의 투여를 인정함. 나) 이후에는 6개월마다 평가를 하여 첫 3 개월째의 평가결과가 유지되면 추가투	
--	---	--

		여를 인정함. (이하 생략)	
※ 관련근거 · Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e, 2025> Chapter 374: Spondyloarthritis · Conn's Current Therapy, 2024> 993-996, Axial Sponyloarthritis · Davidson's Principles and Practice of Medicine, 26e, 2023> 989-1062, Rheumatology and bone disease · ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update · Pan American League of Associations for Rheumatology recommendations for the management of axial spondyloarthritis, 2023 · 2019 update of the Americal College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Sponyloarthritis Research and Treatment Network Recommendation for the Treatment of Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis · Johanna Callhoff, et al. Efficacy of TNFa blockers in patients with ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis: a meta-analysis Ann Rheum dis, 2015, Jun, 74(6), 1241-8 · Dougados, M., et al. Symptomatic Efficacy of Etanercept and Its Effects on Objective Signs of Inflammation in Early Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis & Rheumatology, 2014, 66(8), 2091-2102. · Mitumasa Kishimoto, et al. Clinical characteristics of non-radiographic versus radiographic axial spondyloarthritis in Asia and non-radiographic axial spondyloarthritis in other regions: results of the cross-sectional ASAS-COMOSPA study, RMD open, 2021, 7:e001752 · Xabier Michelena, et al. Non-radiographic versus radiographic axSpA: what's in a name?, Rheumatology (Oxford). 2020 Oct 14;59(Suppl 4):iv18-iv24 · Dennis McGonagle, et al. A strategy towards disentangling treatment refractory from misdiagnosed axial Spondyloarthritis, Autoimmunity Reviews, Volume 23, Issue 1, 2024 Jan 103405 · M Rudwaleit, et al. Defining active sacroiliitis on magnetic resonance imaging (MRI) for classification of axial spondyloarthritis: a consensual approach by the ASAS/OMERACT MRI group, Annals of the Rheumatic Disease, 2009, 68(10), 1520-1527 · Robert G W Lambert, et al. Defining active sacroiliitis on MRI for classification of axial spondyloarthritis: update by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2016, 75(11), 1958-1963 · Walter P Maksymowych, et al. MRI lesions in the sacroiliac joints of patients with spondyloarthritis: an update of definitions and validation by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2019, 78(11), 1550-1558 · Xenofon Baraliakos, et al. MRI lesions of the spine in patients with axial spondyloarthritis: an update of lesion definitions and validation by the ASAS MRI working group, Annals of the Rheumatic Disease, 2022, 81(9), 1243-1251 · NICE(2016.2.) · PBAC(2020.11.) · SMC(2013.4.) · AETNA(2025.10.)			